TD1 Acquisition des compétences

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

UE B2 TD 1 Énoncé et corrigé

Dossier A

« Mais je vous l'avais pourtant expliqué ! »

Situation de l'énoncé

Mme Roux, 67 ans, sort demain après une chirurgie. Une IDE passe dans le couloir, debout, et lui explique en quatre minutes : le pansement, trois médicaments, deux rendez-vous et les signes d'alerte. Pendant ce temps, le téléphone de Mme Roux vibre. Elle le regarde et répond : « Oui, oui, j'ai compris. »

Deux heures plus tard, elle rappelle le service : « Je ne sais plus ce que je dois faire. » L'IDE soupire : « Mais je vous l'avais pourtant expliqué ! »

Que peut-on expliquer avec l'attention, la sélection de l'information et la mémoire ?

Corrigé du professeur

Tri permanent : très peu de ce qui est dit est sélectionné, puis traité

Attention divisée : le téléphone impose un changement de tâche, avec un coût et un risque d'erreur

Charge extrinsèque (couloir, debout, interruption) et intrinsèque (pansement, 3 médicaments, 2 rendez-vous, signes d'alerte).

Mémoire de travail très limitée (Cowan : environ 4 blocs)

Pourquoi « avoir entendu » n'est-il pas « avoir mémorisé » ?

Trois étapes : encodage, stockage, récupération. Entendre n'est pas encoder

« Oui, oui, j'ai compris » : familiarité (reconnaissance), pas rappel

Oubli rapide au début (Ebbinghaus)

Sans traitement du sens, la trace est fragile (Craik et Lockhart)

Que changeriez-vous dans la transmission ?

S'asseoir, faire poser le téléphone

3 messages essentiels, au début et à la fin (primauté, récence).

Faire redire avec ses mots (effet de test)

Un seul support écrit, intégré (effet de redondance)

Rappel différé (espacement), par exemple un appel à J+1

Erreur du soignant

Attribuer l'oubli à un manque de sérieux

Croire que dire, c'est transmettre

Se contenter de « vous avez compris ? »

Action professionnelle

Reprendre par téléphone en 3 messages, faire reformuler, noter la transmission sans étiquette

Affirmation à examiner

« Répéter plusieurs fois une information suffit à la mémoriser. »

Choisissez VALIDER, NUANCER ou REJETER, et justifiez en une phrase avec un concept.

REJETER dans sa forme « suffit »

Répéter en boucle (boucle phonologique) maintient l'information un instant, sans la rendre durable

Relire donne une impression de familiarité, pas un rappel (Bjork)

Dunlosky : relire et surligner ont une utilité faible

Ce qui marche : se tester, espacer, donner du sens

Dossier B

« Je suis sûr de ce que j’ai vu »

Un patient est tombé dans un couloir du service entre deux soins. Deux étudiants présents, Léa et Hugo, sont interrogés séparément par la cadre le lendemain.

Léa : « Il s’est levé trop vite, il a heurté la potence, il y a eu un grand bruit. J’ai vu l’aide-soignant lui lâcher le bras. » Hugo : « Il a glissé tout seul. L’aide-soignant n’était pas encore arrivé. » Tous deux affirment être absolument certains de leur version, et chacun trouve que l’autre se trompe.

Un collègue dit à la cadre : « L’un des deux ment, c’est sûr. »

1. Qui ment ?

On ne peut pas le conclure

Deux témoins peuvent être sincères : chacun a perçu, encodé et reconstruit avec ses propres attentes

Un désaccord n'est pas la preuve d'un mensonge

L'œil n'est pas un appareil photo, la mémoire n'est pas un disque dur

2. Quels mécanismes (perception, attention, mémoire, raccourcis de raisonnement) peuvent expliquer deux récits différents ?

Perception : interprétation, pas enregistrement

Attention sélective, cécité attentionnelle (l'un suit le patient, l'autre la potence)

Mémoire reconstructive (Bartlett)

Information postérieure, suggestion (Loftus)

Certitude ≠ exactitude (Talarico et Rubin)

Biais : confirmation, disponibilité (le bruit), ancrage

3. Que doit faire un soignant face à un témoignage très assuré ?

Recueil séparé, par des questions ouvertes et neutres (un mot change le souvenir, Loftus)

Ne pas faire discuter les témoins avant

Distinguer faits et interprétations

L'assurance n'est pas une preuve d'exactitude : un élément du recueil, pas un critère de vérité

Conclure que l'un ment

Privilégier la version la plus assurée

Poser des questions orientées (« il a bien glissé, n'est-ce pas ? »)

Recueil séparé, questions neutres, faits distingués des interprétations, aucune conclusion sur la sincérité

« Une émotion forte rend forcément le souvenir plus fiable. »

ou NUANCER si l'argument est solide

L'émotion augmente la certitude et la vivacité du souvenir, pas nécessairement son exactitude (Talarico et Rubin)

« Forcément » rend l'affirmation fausse

Piège de lecture : « plus sûr » ne veut pas dire « plus fiable »

Dossier C

« Il n’est vraiment pas motivé »

Un étudiant infirmier, en stage, dit : « M. Garnier, 62 ans, obèse. Il sait qu’il doit marcher 30 minutes par jour et perdre du poids. Il ne le fait pas. Donc il n’est pas motivé. »

M. Garnier, interrogé, dit : « Ma femme veut que je marche. Moi, 30 minutes par jour, avec mes genoux, je me dis que je n’y arriverai jamais. J’ai essayé deux fois, j’ai tenu deux semaines. Je ne sais pas par où commencer. »

1. Attaquez la conclusion « donc il n’est pas motivé ».

Motivation = processus (déclencher, orienter, maintenir), pas un objet que l'on a ou non

Entre « je sais » et « je fais » : représentations, croyances, sentiment de capacité

« Pas motivé » est une étiquette, pas une explication

Piège : conclure sur le comportement sans interroger le patient (biais de confirmation)

2. Distinguez besoin, désir, préférence et motivation, puis direction, intensité et persistance : que peut-on dire de M. Garnier ?

Direction : présente (il essaie, il en parle)

Intensité : faible ou irrégulière

Persistance : deux semaines, deux fois

Sentiment d'efficacité (Bandura) : « je n'y arriverai jamais ». Utile ≠ capable

Deci et Ryan : autonomie (« ma femme veut » : régulation externe ou introjectée), compétence (objectif trop haut)

3. Reformulez « il n’est pas motivé » en une hypothèse psychologique plus rigoureuse.

« M. Garnier semble percevoir l'objectif de 30 minutes par jour comme hors de portée à cause de ses genoux, doute de sa capacité à le tenir, et agit surtout sous la pression de son entourage, ce qui fragilise la persistance. »

Expliquer par un trait (« pas motivé »)

Imposer un objectif lointain, ne pas explorer les obstacles

Poser une étiquette dans les transmissions (prophétie autoréalisatrice)

Explorer obstacles et ressources ; objectif proximal choisi par lui (par exemple 10 minutes, 3 fois par semaine) ; valoriser les deux semaines tenues

« Un patient non observant manque de motivation. »

Observance : logique de conformité passive ; adhésion : implication active, partenariat

Avant de conclure, a-t-on cherché à comprendre pourquoi ?

Facteurs multiples : traitement, maladie, patient, système de soins, environnement

Deuxième affirmation

« Une récompense augmente toujours la motivation. »

ou REJETER

Deci, 1971 : une récompense vécue comme contrôlante peut réduire l'intérêt

Vécue comme reconnaissance d'une compétence, elle peut le nourrir

Dossier D

« Pourtant, il connaît les risques ! »

M. Perrin, 45 ans, fume un paquet par jour. Il dit à l’infirmière : « Je sais très bien que c’est dangereux. Mon père est mort d’un cancer du poumon. Mais pour l’instant, je ne veux pas arrêter. »

Un étudiant propose : « Il faut lui réexpliquer les risques, il ne doit pas assez les connaître. »

1. Que faut-il lui expliquer de plus ?

Pas forcément quelque chose

Il sait déjà (son père) : le problème n'est pas un déficit d'information

Fossé intention-comportement : environ la moitié seulement des intentions se concrétisent

« Pour l'instant, je ne veux pas arrêter » : il n'est pas prêt, il n'est pas ignorant

2. Quels éléments du Health Belief Model, du stade du changement et du sentiment d’efficacité repérez-vous ?

HBM : gravité perçue élevée ; vulnérabilité personnelle à explorer ; bénéfices et obstacles perçus ; signaux d'action

Stade : précontemplation (contemplation si un doute apparaît)

Sentiment d'efficacité : à explorer (tentatives antérieures)

Représentations (Leventhal) : cause, conséquences, contrôle, peut-être marquées par la mort du père

3. Quelle(s) question(s) poseriez-vous ?

« Avez-vous déjà pensé à changer ? »

« Avez-vous déjà essayé, même sans succès ? »

« Qu'est-ce qui vous ferait envisager d'essayer maintenant ? »

« Qu'est-ce qui rend l'arrêt difficile, concrètement ? »

Ne pas deviner à sa place

Répéter les risques

Proposer d'emblée un calendrier d'arrêt ou un traitement : réponse décalée pour un patient en précontemplation

Juger

Reconnaître ce qu'il sait, explorer obstacles et avantages perçus, respecter son rythme, sans jugement ni pression

« Le patient continue de fumer parce qu’il ne connaît probablement pas suffisamment les risques. »

Information et comportement ne coïncident pas

Savoir le risque est rarement le maillon manquant

Entre « je sais » et « je fais » : représentations, croyances, stade du changement, sentiment de capacité

Dossier E

« Elle panique pour une prise de sang »

Une patiente de 28 ans entre dans l’espace de prélèvements d’un hôpital. Elle transpire, ses mains sont moites, elle respire vite : « Rien que l’odeur de l’hôpital, je commence à paniquer. » Elle précise

qu’à 9 ans, lors d’une hospitalisation, on l’a piquée plusieurs fois de suite.

Un soignant lui répond : « Mais c’est juste une prise de sang, ce n’est rien ! »

1. Quelles lectures possibles de cette réaction (émotion et activation physiologique, évaluation, expérience antérieure, apprentissage par association, régulation) ?

Pavlov : piqûre (SI) → peur (RI) ; odeur = stimulus neutre devenu conditionnel → panique ; généralisation

Schachter et Singer : activation peu spécifique + interprétation (« je vais mal »)

Lazarus : évaluation primaire (menace), secondaire (ressources faibles)

Russell : affect désagréable et activé

Skinner : l'évitement est un renforcement négatif

2. Quelle intervention aurait du sens, laquelle risquerait d’aggraver les choses ?

Sens : valider l'émotion ; expliquer la réaction du corps ; annoncer les gestes, adapter l'environnement (Gross : modification) ; distraction (attention) ; respiration lente (modulation) ; réévaluation

Extinction : à nommer, sans détailler une technique

Aggrave : minimiser, ridiculiser, pousser à masquer (suppression), forcer

3. Pourquoi la phrase « ce n’est rien » pose-t-elle problème ?

« Ce n'est rien » nie l'émotion

L'émotion signale ce qui compte pour la personne

Elle ne change pas l'évaluation : la patiente perçoit toujours un enjeu et des ressources insuffisantes (Lazarus)

Les émotions ne sont ni irrationnelles ni infaillibles : des informations à examiner

Invalider (« ce n'est rien »)

Croire à un caprice

Interpréter à sa place

Écouter, expliquer, adapter l'installation, proposer une stratégie de régulation, noter la peur dans le dossier (sans étiquette)

« Deux personnes placées dans la même situation devraient ressentir la même chose. »

La réaction dépend de l'enjeu perçu et des ressources perçues (Lazarus)

Même situation, émotions différentes : l'oral dans dix minutes

Historique, évaluation et régulation varient d'une personne à l'autre

Dossier F

« Je regarde comment fait l’autre »

Une étudiante infirmière raconte : « Au premier pansement, j’avais beau connaître la théorie, je n’y arrivais pas. Après avoir regardé plusieurs fois mon tuteur, puis l’avoir fait avec lui, je me suis sentie capable de le réaliser seule. »

1. Quels mécanismes de Bandura retrouvez-vous ?

Apprentissage par observation : le tuteur est le modèle

Quatre processus : attention, rétention, reproduction, motivation

Apprentissage ≠ performance

Savoir ≠ savoir-faire : mémoire procédurale

Façonnement (Skinner) : approximations successives

2. Quelles sources du sentiment d’efficacité personnelle identifiez-vous ?

Expériences de maîtrise (« je l'ai fait avec lui ») : source la plus puissante

Observation d'une personne comparable

Persuasion verbale, si elle est crédible et personnalisée

États physiologiques et émotionnels (fatigue, anxiété) : altèrent la perception de ses capacités

3. Que peut faire concrètement un encadrant pour augmenter le sentiment d’efficacité d’un étudiant ?

Démontrer, faire avec, laisser faire seul

Fractionner le geste, objectifs proximaux

Retours précis et crédibles

Adapter la difficulté, ni trop facile ni trop difficile

Choisir un moment où l'étudiant est reposé

Croire que la théorie suffit

Juger sur un premier échec

Encourager de façon générique

Plan d'encadrement progressif, avec retours précis à chaque étape

« Quelqu’un qui a une bonne estime de lui-même est forcément confiant dans toutes ses capacités. »

Estime de soi (valeur globale) et sentiment d'efficacité (confiance pour une tâche précise) sont distincts

Exemple : bonne estime de soi, faible sentiment d'efficacité pour parler en public

Compétence réelle : une troisième notion à ne pas confondre

Questions de révision

1. Citez les trois étapes de la mémoire et expliquez pourquoi « hocher la tête » ne prouve pas qu'une information a été encodée.

Encodage, stockage, récupération. Hocher la tête relève de la familiarité (reconnaissance), pas de l'encodage : lire ou entendre n'est pas encoder.

2. Un bip s'arrête quand on boucle sa ceinture et l'on la boucle plus vite ensuite. Quel type d'apprentissage, et en quoi n'est-ce pas une punition ?

Renforcement négatif : on retire un stimulus désagréable (le bip) et le comportement augmente. Une punition, elle, fait diminuer le comportement.

3. Deux personnes vivent la même situation et ressentent des émotions différentes. Expliquez avec les deux évaluations de Lazarus.

Primaire : la situation est-elle importante pour moi (menace, perte, défi, sans enjeu) ? Secondaire : ai-je les ressources pour y faire face ? Même situation, enjeu et ressources perçus différents, donc émotions différentes.

4. Quelle différence entre « je pense que c'est utile » et « je pense être capable de le faire » ? Citez une source du sentiment d'efficacité.

« Utile » : valeur perçue. « Capable » : sentiment d'efficacité personnelle (Bandura), confiance pour une tâche précise. Sources : expériences de maîtrise, observation, persuasion verbale, états physiologiques et émotionnels.

5. Quelles sont les trois dimensions de la motivation ? Donnez un exemple pour l'une d'elles.

Vers quoi, avec quelle énergie, pendant combien de temps. Exemple : deux étudiants choisissent de réviser (même direction) ; l'un pense à autre chose (intensité faible) et abandonne au premier exercice raté (persistance faible).

6. VALIDER, NUANCER ou REJETER : « Un patient qui connaît le risque modifiera plus facilement son comportement. » Justifiez avec deux notions du cours de psychologie de la santé.

NUANCER ou REJETERInformation et comportement ne coïncident pas : fossé intention-comportement (environ 50 % des intentions se concrétisent), Health Belief Model, sentiment d'efficacité, stade du changement. Savoir le risque est rarement le maillon manquant.

Liens à retenir

Méthode

Lire la situation avant de choisir une théorie. Nommer les indices, proposer plusieurs lectures possibles et justifier le concept retenu. Un comportement observable ne permet pas de connaître directement toutes les pensées de la personne.

Information et comportement

Connaître un risque ne garantit pas un changement. Explorer représentations, obstacles, ressources, stade du changement et sentiment d'efficacité. Donner une information supplémentaire n'est pas toujours la réponse au problème rencontré.

Émotions

Rechercher l'enjeu perçu et les ressources pour y faire face. Une réaction forte à un soin peut être liée à une expérience antérieure ou à l'apprentissage associatif. La minimiser peut empêcher la personne de se sentir comprise.

Motivation

Direction : but visé. Intensité : effort mobilisé. Persistance : maintien dans le temps. Explorer la valeur de l'activité et la possibilité de choisir, plutôt que déduire un manque de volonté d'un seul comportement.

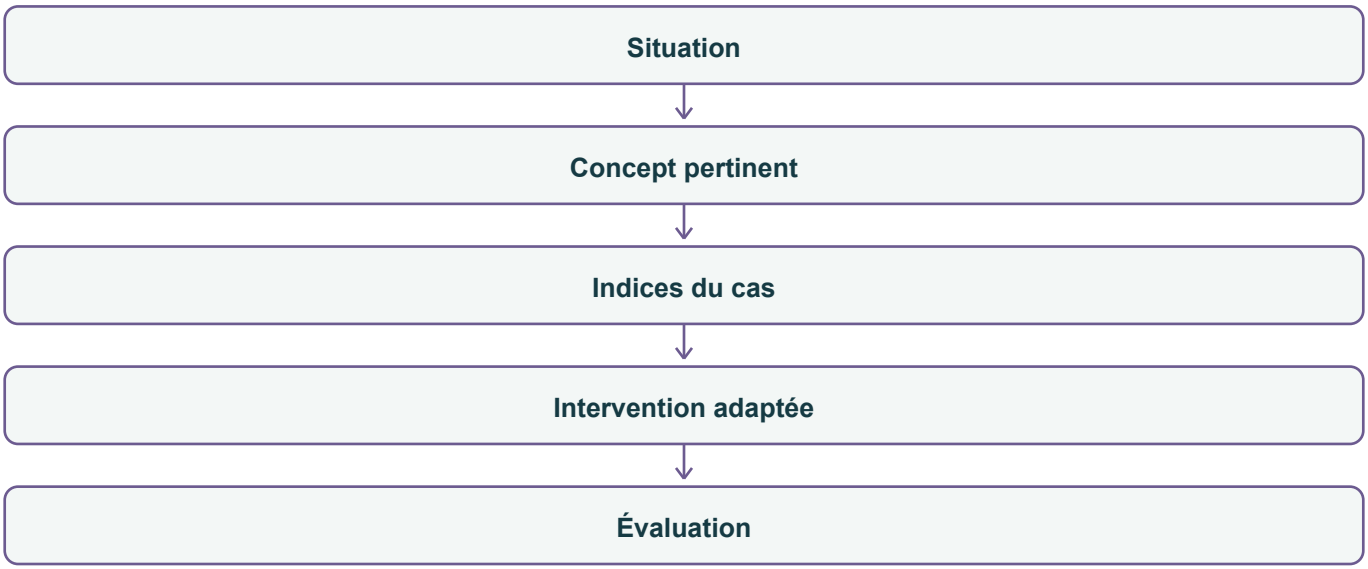
Apprendre un geste

Observer un modèle ne suffit pas : l'étudiant doit pouvoir retenir, reproduire et s'engager. Démonstration, pratique accompagnée, retours précis et difficulté progressive soutiennent la compétence et le sentiment d'efficacité.

Répondre au TD

Utiliser la forme : fait du cas, concept, explication, conséquence pour le soin. Distinguer correction proposée par l'enseignant et interprétation personnelle. Plusieurs concepts peuvent s'articuler sans être interchangeables.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Estime de soi et efficacité personnelle sont-elles identiques ? Non.

« Ce n’est rien » peut-il invalider un vécu ? Oui.

Une théorie suffit-elle à expliquer toute une situation ? Non.

Sources et portée

UE B2 TD1 ENONER ET CORRECTION.docx

Ressource Moodle correspondante